DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MARTINEZ **Identificación** CC 1264660
Edad: 95 AÑOS **Empresa:** EMSSANAR S.A.S SUBSIDIADO-2025-2
Sala: SALA DE ENDOSCOPIA **Fecha programación de cirugía:** 10/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	**452305**	**COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIA**	ANK	

Cirujano: JOHANN MARIO ALVAREZ GIL **Especialidad:** GASTROENTEROLOGIA
Vía:

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES257 JOHANN MARIO ALVAREZ GIL **Especialidad** GASTROENTEROLOGIA
452305 **COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIA**
Dx Preoperatorio: C188 LESION DE SITIOS CONTIGUOS DEL COLON

Dx Postoperatorio: K573 ENFERMEDAD DIVERTICULAR DEL INTESTINO GRUESO SIN PERFORACION NI ABSCESO

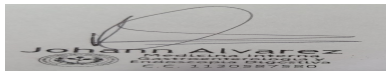
Tipo de Herida: LIMPIA **Tipo de Anestesia:** GENERAL **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
Cantidad de Sangrado: 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 10/11/26 **Fecha Final** 10/11/26
Hora Inicio 12:10:00 **Hora Final** 12:22:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:
PROCEDIMIENTO CON SEDACIÓN BAJO ANESTESIOLOGIA GENERAL DRA ELBIA RODRIGUEZ(FENTANILO, LIDOCAINA, PROPOFOL)***
SE UTILIZARON TODAS LAS MÉDICAS DE BIOPROTECCIÓN PARA PREVENIR LA INFECCIÓN DEL PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y PACIENTE. (BATA ANTIFLUIDOS, N95, CARETA Y DOBLE GUANTE).
PROCEDIMIENTO REALIZADO CON EQUIPO OLYMPUS CV-180 EVIS EXERA II
REALIZADO POR JOHANN ALVAREZ.
****COLONOSCOPIA****
***INDICACIÓN: Hmeatoquecia
INSPECCIÓN: Normal
TACTO RECTAL: Normal
COLONOSCOPIA: Explorado hasta colon transverso proximal donde se observa lesión friable, ulcerada, con signos de infiltración que compromete el 100% de la circunferencia generando estenosis del 90 % que impide franquear a proximal del cual se toman múltiples biopsias (10 Fg). Se observa en todo el trayecto múltiples orificios diverticulares sin sangrado, sin edema. En recto aprox a 5 cm de reborde anal se observó 2da lesión irregular que compromete el 30% de la circunferencia, friable de la cual se toman múltiples biopsias (5 Fg). Canal anal paquete hemorroidal. Procedimiento sin complicaciones aparentes.
Preparación Boston CT: 3, CI: 3 6/6.
BIOPSIA: FRASCO 1: Lesión colon transverso. FRASCO 2: Lesión de recto
***CONCLUSIÓN:
1. LESIÓN COLON TRANSVERSO PROXIMAL: NEO ?
2. DIVERTICULOSIS TRAYECTO VALORADO
3. LESIÓN DE RECTO A ESTUDIO: ADENOMA VELLOSO EXTENSO VS SINCRÓNICO
4. HEMORROIDES GRADO I/IV

Complicaciones : **SI** [ ] **NO** [X]

Tejidos enviados a patología : **SI** [X] **NO** [ ]
FRASCO 1: LESIÓN COLON TRANSVERSO. FRASCO 2: LESIÓN DE RECTO

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS



JOHANN MARIO ALVAREZ GIL
Reg. 1130587580
GASTROENTEROLOGIA

*** * * FIN DEL REPORTE * * ***